ODO-INF02 | Edición 03 | Revisión: 09/10/2026

Organización del área de reprocesamiento y flujo unidireccional

Objetivo

Establecer una secuencia verificable para organización del área de reprocesamiento y flujo unidireccional, articulada con la oferta y los recursos reales del consultorio.

Alcance y responsabilidades

Aplicación en odontologia ambulatoria, dentro de competencia y modalidad habilitada. Responsable clínico o del proceso: asignar en la adopción; personal de apoyo actúa según rol y entrenamiento. Confirmar aplicabilidad al prestador y sede antes de adoptar.

Términos de uso

Criterio: condición que se verifica. Evidencia: soporte auténtico de lo realizado. No conformidad: diferencia frente al criterio aplicable. Contención: medida inmediata para impedir daño. Cierre: corrección cuya eficacia se comprobó. Los términos clínicos/técnicos particulares se interpretan conforme a la guía o manual indicado.

Zonificación

Identificar recepción contaminada y limpieza; zona limpia de secado, inspección y empaque; zona de esterilización y descarga; almacenamiento estéril protegido. Segregar carros, bandejas, útiles y transporte; no cruzar instrumental contaminado con paquetes liberados.

Recursos

Comprobar poceta y grifería adecuadas, protección para limpieza, método de secado compatible, iluminación/inspección, mesón, barreras y almacenamiento. Definir si prestador exceptuado de central o central propia; requisitos específicos se cotejan en matriz normativa y nuevo manual, sin equiparar ambos.

Conducta

Acceso limitado a personal competente, ropa/protección según zona y tarea, higiene al pasar a zona limpia. Prohibir alimentos, documentos clínicos abiertos y objetos ajenos. Registrar inspecciones, mejoras y proceso alternativo si se pierde segregación.

Aplicación paso a paso y respuesta a desviaciones

Aplicabilidad y responsables

Relacionar este documento con sede, servicio, modalidad y tareas realmente realizadas. Designar ejecutor, suplente y revisor por nombre/rol; comprobar competencia y recursos. Si No aplica, justificar con oferta real y criterio normativo, sin utilizarlo para ocultar una actividad que sí se ejecuta.

Preparación del proceso

Reunir información y soportes descritos en sus secciones: documentos vigentes, equipos o productos identificados, condiciones de sede y proveedores verificados. Revisar fechas, integridad y coherencia entre el soporte y la operación; una certificación de otro equipo o profesional no es intercambiable.

Ejecución y evidencia

Registrar actividades reales con fecha, responsable, resultado y ubicación del soporte. Diferenciar programación de ejecución y solicitud de respuesta recibida. Mantener versión de origen, trazabilidad de cambios y acceso apropiado; no completar registros retrospectivamente sin señalar adenda.

Hallazgos y cierre

Describir incumplimiento, riesgo y medida inmediata. Asignar corrección, responsable y plazo; mantener estado Pendiente mientras no exista soporte verificable. La reapertura o aprobación exige revisión del resultado, no solo afirmación de cumplimiento.

Seguimiento del estándar

Revisar muestra de registros y observar práctica/recursos. Comparar requisito, evidencia documental y condición real; analizar repetición de fallas y actualizar controles. Conservar acuerdos y permisos auténticos cuando el proceso depende de terceros.

Frecuencia y puntos de control

Ejecutar en cada atención, tarea o cambio que active este proceso. Definir periodicidad de revisión por riesgo, oferta, fabricante y norma aplicable; registrar la programación local. La periodicidad local no se presenta como exigencia legal universal.

Registros relacionados

Usar los formatos individuales vinculados al código ODO-INF02 en el índice maestro. Asociar fecha, responsable, resultado y ubicación de evidencia. Las historias y consentimientos diligenciados se mantienen en expediente reservado; los soportes administrativos no deben exponer datos clínicos.

Verificación, fundamento y adopción

Indicador y método de evaluación

Indicador local propuesto: ejecuciones verificadas con pasos críticos completos / ejecuciones revisadas × 100. Definir periodo, muestra, fuente y meta según riesgo. Con denominador cero anotar no calculable. Registrar además oportunidad y gravedad de desviaciones; no interpretar ausencia de reporte como ausencia de daño.

Acciones correctivas

Describir hallazgo concreto, medida inmediata, causa, acción, responsable y plazo. Verificar eficacia con evidencia posterior antes de cerrar. Si existe riesgo activo o falta competencia/recurso, suspender la actividad afectada y coordinar alternativa segura.

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes. Criterios generales 11.1 y consulta externa 11.2.1; 11.2.2 para oferta especializada que corresponda. La Resolución 2080 de 2026 revocó la 1732 de 2026; no se aplica su manual como régimen vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Instalaciones eléctricas

RETIE: Resolución 40284 de 2026. Un técnico competente determina obligaciones de evaluación/conformidad según instalación y régimen temporal; la plantilla no es certificación.

https://minenergia.gov.co/es/misional/energia-electrica-2/reglamentos-tecnicos/reglamento-t%C3%A9cnico-de-instalaciones-el%C3%A9ctricas-retie/

Odontología

Ley 35 de 1989 y Decreto 491 de 1990: ética, ejercicio e información para la decisión clínica. El procedimiento debe estar dentro de competencia y oferta real.

https://www1.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=166609

Reprocesamiento

Resolución 2183 de 2004 y criterios vigentes de habilitación; Resolución 914 de 2025 y manual DMER: vigencia general prevista 03/01/2027 conforme al artículo 15. Revisar transitoriedad del artículo 12 y reglas específicas del tipo de prestador.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_0914_2025.htm

Fuentes técnicas particulares

Consultar versión íntegra y vigente, población y metodología; adaptar con trazabilidad. Una referencia técnica orienta práctica y no es legislación colombiana.

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-2183-de-2004.pdf ;
https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_0914_2025.htm ;
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/manual-practicas-reprocesamiento-dmer.pdf

Soportes auténticos que deben anexarse

Adjuntar documentos de autoridad, títulos/licencias, guías completas, instrucciones del fabricante, contratos o registros reales que correspondan al contenido. No se producen certificados, mantenimientos, planos técnicos ni evidencias de ejecución ficticias.

Adopción y actualización

Completar responsables, recursos, límites y registros; aprobar con autenticación válida y capacitar antes de utilizar. Revisar ante cambio normativo, incidente, tecnología o población. El encabezado permanece vacío para personalización; el contenido es propuesta y no acredita por sí mismo cumplimiento.